内科学含诊断学 循环系统疾病

①左心射血时间延长，主A瓣关闭时间迟于肺A瓣 A2-P2 A2
②左心室肥厚，顺应性↓靠自己负压抽吸回血↓
左心房代偿加强收缩射血，
产生增强的第四心音（本质）

核心精讲·高血压

（性感认识：高血压一线药 ABCD）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、高心病的可能可能最可能

右室肥厚，顺钟向转位，心界向左扩大
心前区/剑突下抬举样搏动-右心问题

高血压病史特别是从未诊治（你不治疗、不听医生的话憋憋出问题；必看主诉）
后负荷↑ ① ② 心肌肥厚、心脏扩大 “门框变大”相对性二闭
左室肥厚、A_2亢进、S_2逆/反常分裂、S_4奔马律、心尖抬举样搏动、心界多向左下扩大、心尖部收缩期杂音
第二心音强弱看主A和肺A里的压力 额外心音

题目只告诉心界向左扩大有可能是向左扩大（右室大）
也可能是向左下扩大（左室大）

S_2 {A2↑（体循环压力↑） P2

二、检查

（一）24 小时动态血压监测

交感N兴奋（+5） 迷走N兴奋（-10） 我是小三八

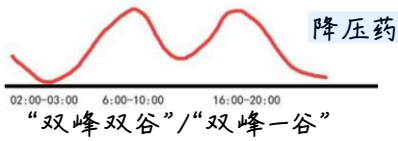
①平均值：<130/80、白天<135/85、夜间<120/70

②发现隐蔽性高血压，诊断 ttsx 白大衣高血压，检查是否存在顽固性难治性高血压，评估血压升高程度、短时变异、昼夜节律、治疗效果

3种降压药>4周仍不达标
≥4种降压药才能达标



血压昼夜波动的日节律



降压药要在高峰时间服用

“双峰双谷”/“双峰一谷”

（二）电子血压计

1.注意事项

①禁烟半小时

②安静，坐位（若取仰卧位则上肢平放于腋中线水平）与心脏同一水平

③非同日测量 3 次

④测量上臂肱动脉：首次诊断时测双侧血压、以后测血压较高侧

2.高血压分级（门槛四九城） 高血压门槛：140/90 十版新增

	正常血压	正常高值	高血压 1 级	高血压 2 级	高血压 3 级	单纯 收缩期高血压	单纯 舒张期高血压
收缩压	<120	120-139	140-159	160-179	≥180	≥140	<140
	和	和/或	和/或	和/或	和/或	和	和
舒张压	<80	80-89	90-99	100-109	≥110	<90	≥90

20 +20 +20 10 +10 +10

老年人由于动脉粥样硬化，弹性储器作用（减小血压波动）↓
出现单纯收缩期高血压，治疗强调收缩压达标

注意：若收缩压和舒张压不在一个等级看较高分级

（三）高血压眼底分级（细仔出众）

I 视网膜动脉变细、反光增强（细针反光）

II视网膜动脉狭窄、动静脉交叉压迫

III上述病变+眼底出血、棉絮状渗出

IV上述病变+视盘水肿